EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	:	HOSPITAL DE SAN CARLOS	N° EGRESO	:	82971
SERVICIO	:	GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA HSC			
FECHA	:	22-04-2024			

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: SAMANTA ROCIO AMAYA .			**RUN**	: 27.330.868-7
F.Nac	: 22-09-1995	**Edad**	: 28 AÑOS, 7 MESES	**Género**	: Femenino
Dirección	: O?HIGGINS 46 Condominio 7i			**Comuna**	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA A	**Teléfono**	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-04-17	**Fecha Egreso**	: 22-04-2024	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Nefritis + Ureteritis Bilateral
Obs Absceso renal

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. N39-OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente hospitalizada en contexto PNA bilateral, derivada desde Clínica los andes
Clínicamente en mejores condiciones generales. Destaca menor dolor en región dorsolumbar bilateral. Niega sintomatología urinaria. No se registran episodios febriles.
Durante estancia en servicio en buenas condiciones generales, eupneica, afebril, con disminución progresiva del dolor.
Examenes de laboratorio con elevación inicial de PCR (hasta 320), actualmente en 33.
Bajo sospecha inicial de anemia, paciente en periodo menstrual.
Función renal conservada. Sin compromiso ELP.
Se valora TC AP CC desde Clínica los Andes (acceso a imágenes) donde impresiona absceso renal (?) no descrito en informe.
UCT negativo. HC de Clínica los Andes negativos.
Se realiza control con UroTC que reporta:
Se evidencia riñon derecho falta de perfusión a la inyección de contraste con áreas hipodensas en parénquima renal, que puede corresponder a un proceso infeccioso (PNA) asociado a refracción de planos grasos perirrenales y realce ureteral ipsilateral.
En vista de condiciones y de evolución favorable se decide alta médica con Hodom. Valoración en segunda instancia por Cirugía (Dr Inostroza – por observación de Absceso Renal). Extender terapia ATB.

PLAN DE MANEJO:

Valoración al alta en manejo conjunto.
Se dejan firmadas interconsultas.

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo asistido
2. Regimen común - Favorecer hidratacion VO abundante
3. Ceftriaxona 2gr ev día (cumplir por 14 días)

4. Paracetamol 1 gr vo c8h SOS
5. Metamizol 300mg vo c8h SOS
6. Control Poli Medicina Interna 30 días
7. Control Poli Cirugía – Dr Inostroza. 15 días
8. Control SU SOS

EXÁMENES Y RESULTADOS

Ex 22/04/24 PCR 33, Hb 12.9, GB 4.8, Plaq 428, Reticulocitos 0.4, VHS 73, b12 1300, Proca 0.6, Ferritina 81. Crea 0.8
EXS 18.4.24 CREA 0.7, PCR 320, HB 10.7, GB 15000, PLT 225000, PROC 4

Jaime Montecino Mejias
MEDICO TRATANTE
8826535-1

JEFE SERVICIO